**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**3ª Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha**

Rua Protásio Alves, 80, 3º andar - Bairro: Alto Pedregal - CEP: 95300000 - Fone: (54)3046-9850 - Email: frlagverm3vjud@tjrs.jus.br

**TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5003734-95.2024.8.21.0057/RS**

**REQUERENTE**: ROSANGELA TEREZINHA MERIB GONCALVES

**REQUERIDO**: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

# SENTENÇA

**Relatório.**

ROSANGELA TEREZINHA MERIB GONÇALVES ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência para fornecimento de medicamento em face de IPE - SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, partes já qualificadas, alegando em síntese que na data de 14/06/2024, a autora foi diagnosticada com carcinoma invasivo do tipo não especial na mama esquerda, grau histológico: grau 3 de nottingham (formação tubular/glandular 3, pleomorfismo nuclear 3 e índice mitótico 2), e carcinoma invasivo do tipo não especial, na mama direita, grau histológico: grau 3 de nottingham (formação tubular/glandular 3, pleomorfismo nuclear 3 e índice mitótico) e necessita de tratamento noeadjuvante com quimioterapia associado ao uso de pembrolizumabe 200MG a cada 3 semanas. Relatou que é usuária do IPE-Saúde e PAMES e solicitou o medicamento acima descrito, entre outros, por meio do Guia de Autorização IPE Saúde na data de 12/07/2024, porém teve negado o tratamento. Acrescentou que atualmente a doença se apresenta muito sintomática, de rápida evolução com a presença de forte dor, inchaço nas mamas, fraqueza, entre outros sintomas da doença, e para o tratamento, precisa com urgência do pembrolizumabe. Informou que por ser assalariada e estar afastada do emprego não tem como despender de recursos no valor estimado do tratamento que são 2 doses mensais de injeções a cada 3 semanas, as quais conforme orçamentos feitos, o mais barato custa em média (duas doses) o valor de R$ 44.448,00, além dos custos para aplicação do imunizante e a aquisição dos demais medicamentos e deslocamento até a cidade de Passo Fundo onde realizará todas as quimioterapias e demais procedimentos. Destacou que o IPE deve cobrir medicamentos de alto custo para tratamento oncológico sempre que houver prescrição médica, já que o plano de saúde IPE tem cobertura para o câncer, o que consequentemente deve fornecer o tratamento completo. Sendo assim, requereu o deferimento da liminar, a fixação de pena pecuniária em valor não inferior a 01 salário mínimo por dia de atraso, a procedência do pedido formulado, a produção de todos os meios de prova, a concessão dos benefícios da AJG e a citação da requerida. Ademais, informou o desinteresse na audiência de conciliação. Deu se à causa o valor de R$ 533.386,80. Juntou documentos (evento 1, DOC1).

Em decisão, recebida a inicial, deferida a AJG e deferido o pedido formulado em sede de tutela de urgência de natureza antecipada (evento 3, DOC1).

Intimada, a parte ré juntou o comprovante de cumprimento da liminar, afirmando que foi autorizado o medicamento em 13/08/2024 e sugeriu a renovação periódica do laudo médico em período razoável, conforme o caso, para a continuidade das liberações do tratamento. Juntou documentos (evento 10, DOC1).

Em contestação, a parte ré discorreu acerca das leis que regem o IPE-SAÚDE, destacando que é administrado por uma autarquia estadual, pelo que devem ser observados os princípios que norteiam a Administração Pública, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Dissertou sobre a cobertura de medicamentos para o tratamento da patologia que acomete a parte autora, sustentando que a autarquia não pode ser compelida a fornecer medicamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Expôs os medicamentos que são cobertos pela autarquia, para o tratamento da enfermidade que acomete a autora. Argumentou acerca da sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde - FAS/RS, que é feita às custas dos recursos oriundos do Fundo de Assistência à Saúde, estabelecido pela Lei nº 12.066/2004, destacando as despesas crescentes com os atendimentos pelo plano, alegando que a determinação de extensão da cobertura do IPE-Saúde, pela via judicial, ofende o princípio constitucional da separação de poderes, sendo necessária a observação das tabelas do IPE-SAÚDE, alegando ser ilegal o reembolso de tratamento que não integre a tabela de cobertura do IPE-SAÚDE, face à ausência de norma jurídica ou contrato que autorize o reembolso. Requereu a improcedência dos pedidos formulados, condenação do demandante ao pagamento dos honorários de sucumbência em caso de improcedência dos pedidos, isenção do pagamento de custas nos termos da Lei e a realização de todos os meios de prova em Direito admitidos (evento 22, DOC1).

Houve réplica (evento 27, DOC1).

Intimada, a parte ré requereu a produção de Nota Técnica via Natjus, visando analisar a adequação do tratamento postulado pela parte autora ao caso clínico, bem como para verificar a (im)possibilidade de utilização dos tratamentos e alternativas disponibilizadas pela rede pública de saúde (evento 33, DOC1).

Intimada, a parte autora declinou da produção de provas (evento 34, DOC1).

Em decisão, entendida como desnecessária nova consulta, tendo em vista que já houve a consulta da Nota Técnica via Natjus (evento 36, DOC1).

Vieram os autos conclusos para a sentença.

**Decido. Fundamentação.**

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação de medicamentos em que a parte autora postula o fornecimento do fármaco Pembrolizumabe (Keytruda) 200 mg, a cada três semanas, até progressão ou toxidade limitante, conforme laudo médico acostado à' inicial, a fim de realizar o tratamento da patologia que lhe acomete, qual seja, "*CARCINOMA INVASIVO DO TIPO NÃO ESPECIAL, na mama esquerda, grau histológico: grau 3 de nottingham (formação tubular/glandular 3, pleomorfismo nuclear 3 e índice mitótico 2), e CARCINOMA INVASIVO DO TIPO NÃO ESPECIAL, na mama direita, grau histológico: grau 3 de nottingham (formação tubular/glandular 3, pleomorfismo nuclear 3 e índice mitótico 3)*".

Inicialmente, frisa-se que é dever do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul garantir a saúde física e mental dos servidores vinculados ao Plano de Assistência Médica do Instituto. Portanto, é desta autarquia o dever de garantir os preceitos constitucionais. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece: "*A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*"

Com efeito, a Lei nº 12.134/2004, a qual versa sobre a assistência médica oferecida pelo Plano IPE-SAÚDE, em seu art. 2º, dispõe: "*Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde*."

Os arts. 8º e 9º, da Resolução nº 21/79, do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, referem:

*"Art. 8º. O Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.*

*§ 1º. O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa, sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos.*

*Art. 9º. A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:*

*1 – Emergências*

*2 – Consultas Médicas*

*3 – Serviços Complementares*

*4 – Tratamento Ambulatorial*

*5 – Tratamento Hospitalar"*

Por outro lado, em princípio, apenas os atendimentos psiquiátricos e as cirurgias plásticas estéticas ou não éticas são excluídas da cobertura, nos termos dos arts. 411 e 422, da Resolução anteriormente citada. Dessa forma, os dispositivos anteriormente mencionados evidenciam a amplitude da cobertura, que abrange, inclusive, o fornecimento do medicamento do paciente.

Se dentre as especialidades médicas cobertas pelo IPE-SAÚDE encontram-se "os atos necessários ao tratamento", e não envolvendo o pedido o fornecimento de cirurgia plástica ou não ética, não verifico razão plausível a amparar a negativa do instituto réu. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é facultado ao plano selecionar o tipo de tratamento oferecido ao segurado:

*AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR.*

***1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.***

*2.- "É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar." (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013).*

*3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013). (Grifei)*

*AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.*

***1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedentes.***

*2. Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Precedente: AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013).*

*3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 20/09/2013). (Grifei)*

Nesse sentido, também decide o TJ/RS:

*AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO PLANO IPE-SAÚDE. TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO AVASTIN. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não deve ser tolhido o direito da parte autora de ter custeado pelo IPE-SAÚDE o tratamento médico completo que necessita, com os medicamentos indicados pelo médico assistente, porquanto a Lei Complementar Estadual nº 12.134/2004 e a Resolução nº 21/79*

*preveem que serão cobertos pelo IPE-SAÚDE os "atos necessários ao tratamento". 2. Cabe ao profissional habilitado indicar o tratamento e os medicamentos necessários a sua realização, a fim de tratar de forma adequada a doença que acomete sua paciente, não cabendo ao IPERGS discutir sobre a forma do tratamento, devendo custear as despesas de acordo com a prescrição médica. 3. A ausência de previsão orçamentária e da reserva do possível são argumentos que não constituem óbice ao acolhimento da pretensão da parte autora, em especial porque não há nos autos prova de que o IPERGS não tenha condições de arcar com o custo do medicamento solicitado, tampouco que existam outras prioridades a serem atendidas. 4. O direito à indenização por dano moral deve ser caracterizado quando há constrangimento ilegal ou abusivo, violando os direitos de personalidade do indivíduo. 5. Hipótese em que a autora recebeu o atendimento médico necessário, inexistindo prejuízo a ensejar o dano moral pleiteado. 6. Logo, não havendo comprovação da conduta ilícita, culpa do agente, existência de dano, além do nexo de causalidade, inviável o pagamento de indenização por danos morais. 7. O IPERGS é autarquia estadual, pertencente ao Ente Federado Estadual, portanto, no que diz respeito a sua condenação ao pagamento das custas processuais, este é isento, porque o processo tramitou em cartório estatizado, situação essa que caracteriza o instituto da confusão previsto no artigo 381 do CCB. 8. De outra banda, suportará as despesas processuais, exceto as de oficial de justiça, de acordo com a Lei nº 8.121/1985 e decidido pelo Órgão Especial desta Corte na ADI nº 70038755864 e no IIn nº 70041334053. 9. Reexame Necessário, conhecido de ofício, por se tratar de sentença ilíquida, hipótese descrita no enunciado da Súmula nº 490 do STJ, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição. 10. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo Nº 70064929748, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 24/06/2015)*

Ressalto não desconhecer a determinação de que o segurado do IPE SAÚDE deve utilizar os procedimentos disponibilizados pelo plano de saúde, inclusive com requerimento administrativo da medicação postulada. Entretanto, diante da gravidade da situação, o plano de saúde deve fornecer o tratamento requerido, estando documentado o indeferimento do pedido administrativo formalizado pelo segurado.

No caso dos autos, a necessidade do uso dos medicamentos está demonstrada, principalmente, pelo laudo médico (evento 1, DOC14), assinados por profissional devidamente habilitado, o que é suficiente para comprovar a alegação da parte requerente, ou seja, a necessidade do uso do medicamento pleiteado. Salienta-se, no ponto, que o laudo médico não é genérico e especifica o motivo da prescrição.

Além disso, há parecer do NatJus favorável ao pedido da autora (evento 11, DOC1):

**Conclusão**

**Tecnologia:** PEMBROLIZUMABE

**Conclusão Justificada:** Favorável

**Conclusão:** CONSIDERANDO o diagnóstico de carcinoma de mama triplo negativo localmente avançado.
CONSIDERANDO a solicitação de PEMPROLIZUMABE neste contexto.
CONSIDERANDO o benefício visto em literatura médica, bem como recomendação dos principais orgãos internacionais
CONCLUI-SE que HA DADOS TECNICOS que justifiquem o uso de PEMBROLIZUMABE neste contexto.

**Há evidências científicas?** Sim

**Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?** Sim

**Justificativa:** Com risco potencial de vida

**Referências bibliográficas:** 1- Event-free Survival with Pembrolizumab in Early TripleNegative Breast Cancer. Schmid P, Cortes J, Dent R, Pusztai L, McArthur H, Kümmel S, Bergh J, Denkert C, Park YH, Hui R, Harbeck N, Takahashi M, Untch M, Fasching PA, Cardoso F, Andersen J, Patt D, Danso M, Ferreira M, Mouret-Reynier MA, Im SA, Ahn JH, Gion M, Baron Hay S, Boileau JF, Ding Y, Tryfonidis K, Aktan G, Karantza V, O'Shaughnessy J, KEYNOTE-522 Investigators N Engl J Med. 2022;386(6):556.

**NatJus Responsável:** Nacional

**Instituição Responsável:** Hospital Israelita Albert Einstein

**Nota técnica elaborada com apoio de tutoria?** Não

**Outras Informações:** ndn

Nesse sentido, entendo que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir enquanto obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Destaco que o médico da parte autora, por acompanhar o paciente desde o início de seu problema, é quem - ao menos em tese - tem as melhores condições de indicar o tratamento mais adequado, não podendo o direito constitucional à saúde ser limitado a uma simples tabela ou protocolo.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do RS tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão em tabela do IPERGS não é o suficiente para negativa de autorização de tratamento indicado por médico credenciado, conforme se verifica pelos precedentes a seguir:

*"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PREVIDÊNCIA. IPÊ-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NEXAVAR 200MG. DEMANDANTE PORTADOR DA PATOLOGIA ESPECIFICADA PELO CID 10 C 22 NEOPLASIA MALIGNA DE FÍGADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E HARMONIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ADEQUAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte era pacífica quanto à responsabilidade do IPERGS pela assistência médica dos seus segurados. Entendia-se que o artigo 2º da LC nº 12.134/04, combinado com as disposições da Resolução nº 21/1979, autorizava o entendimento no sentido de que o critério utilizado pela Administração Pública para definição dos serviços oferecidos pelo IPÊ-Saúde era o da exclusão expressa, de modo que, em princípio, todos os serviços de tratamento hospitalar ou ambulatorial curativos eram entendidos como custeados, exceto os expressamente excluídos.* ***2. A Lei Complementar nº 15.145/18, que dispõe sobre o IPE-Saúde, refere que o plano de saúde integra atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento. O parágrafo primeiro do artigo 4º da nova lei, disciplina que os tratamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do IPERGS restam excluídos da cobertura do plano de saúde, sendo oportuno assinalar***

***que o parágrafo segundo exige, ainda, aprovação do Órgão Gestor para inclusão de novos procedimentos. 3. Contudo, em que pese as disposições da nova lei, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Inclusive, válido ressaltar que, de acordo com as Recomendações em Oncologia do próprio Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul elaboradas pelo Comitê Científico de Oncologia e Hematologia da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul as orientações ali constantes não têm pretensão de serem completas ou definitivas , restando destacado, ainda, que a atuação oncológica é um fenômeno continuado que requer revisões frequentes . 4. Assim, considerando que as Recomendações são de 2010, desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia.*** *5. O bloqueio de valores, cujo afastamento requer o agravante, é técnica utilizada para constranger o Estado (lato sensu) à satisfação do comando judicial em caso de eventual descumprimento do que restou consignado pelo juízo. Portanto, descabe afastar tal condenação. 6. Levando em consideração a singularidade do caso, eis que o demandante postula fornecimento por tempo indeterminado de medicamento de alto custo, razoável e necessária a realização de prova pericial médica, conforme requerido pelo agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079550992, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/12/2018)" (Grifei)*

*"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON METASTÁTICO. REGORAFENIBE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. DESCABE AO PLANO DE SAÚDE PÚBLICO SELECIONAR O TIPO DE MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DO SEGURADO.* ***A Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE), prevê a cobertura de atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento da patologia de que padece o beneficiário. "Em que pese a edição da Lei Complementar nº. 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº. 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão no Protocolo Oncológico 2010 e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurada da autarquia. O Protocolo Oncológico aplicado pelo IPERGS se reporta ao ano de 2010, passados, pois, mais de sete anos, não tendo as orientações lá contidas pretensão de serem completas ou definitivas, sendo a atualização oncológica um fenômeno continuado que requer revisões frequentes."*** *("ut" trecho da ementa do Acórdão do Agravo de Instrumento Nº 70078464625). No caso concreto, restou demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento postulado ao adequado tratamento da patologia que acomete o demandante. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR PARTICULAR. REDUÇÃO. Verba arbitrada com observância dos vetores dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e parâmetro adotado por esta Câmara em situações similares. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 70084158856, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 04-06-2020)" (Grifei)*

Sendo assim, é indiscutível a responsabilidade do IPE-Saúde pelo fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da parte autora, uma vez que está fundada na lei a sua responsabilidade em fornecer o atendimento médico e hospitalar e o tratamento, assim como os atos necessários ao diagnóstico e tratamento, razão pela qual não há como sustentar a justificativa da autarquia no sentido de que não há cobertura para o tratamento solicitado, bem como o médico que acompanha o paciente é quem tem condições de receitar o fármaco mais adequado ao tratamento, devendo prevalecer sua prescrição em face de parecer ou afirmação genérica acerca da possibilidade de utilização de medicamento diverso disponível nas tabelas da Autarquia.

**Dispositivo**.

**Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ROSANGELA TEREZINHA MERIB GONCALVES em face de IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL para o fim de confirmar a antecipação de tutela e CONDENAR a parte ré a fornecer à requerente o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) 200 mg, a cada três semanas, até progressão ou toxidade limitante, conforme o laudo médico (evento 1, DOC13 e evento 1, DOC14), de forma continuada e na quantidade postulada pela parte autora, enquanto perdurar a sua necessidade.**

Em caso de descumprimento, será bloqueado o valor correspondente.

Isento o requerido do pagamento de custas processuais.

No tocante aos honorários advocatícios devidos pelo requerido em favor do procurador da parte autora, que fixo de acordo com o valor indicado na Tabela de Honorários da OAB/RS para o ajuizamento de ação de procedimento ordinário cível (item 4.1), qual seja, R$ 8.441,84 (oito mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) com fundamento no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC, uma vez que, no caso, o valor da causa não deve ser tomado como base de cálculo da verba honorária, pois não corresponde ao efetivo proveito econômico da parte litigante, eis que de valor inestimável.

Intimação e publicação automáticas. Sem necessidade de registro.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **GERSON LIRA, Juiz de Direito**, em 21/06/2025, às 11:14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084474904v8** e o código CRC **9bceb2fb**.